

①

細胞障害性抗がん薬

分類・作用機序・臓器毒性

1 薬剤の分類マップ

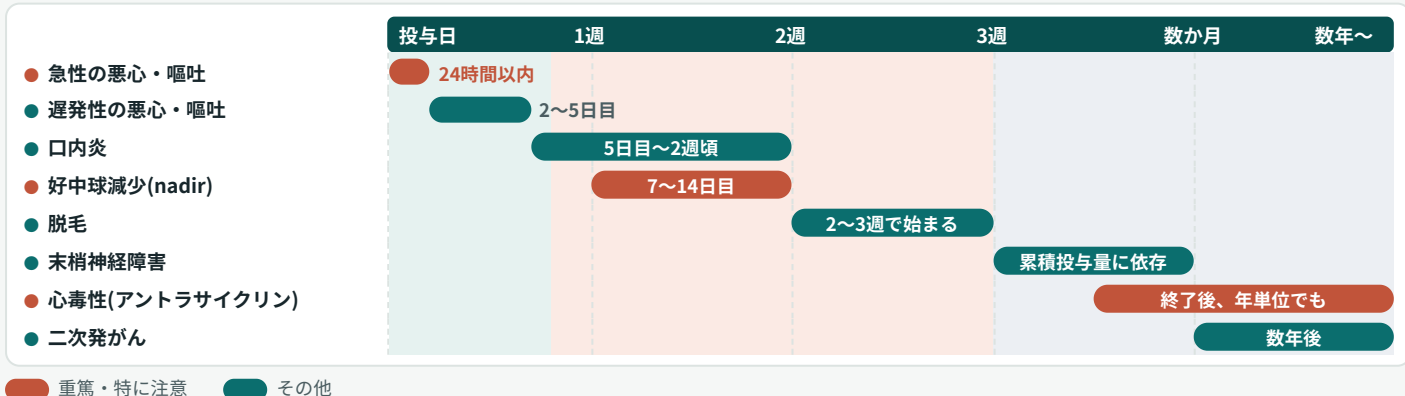
DNAに作用 DNAを架橋して複製を阻害	アルキル化薬 シクロホスファミド イホスファミド ベンダムスチン テモゾロミド 白金製剤 シスプラチン カルボプラチン オキサリプラチン
代謝拮抗薬 偽の材料でDNA合成を停止	葉酸代謝拮抗薬 メトトレキサート ペメトレキセド ピリミジン代謝拮抗薬 5-FU S-1 カペシタビン ゲムシタビン プリン代謝拮抗薬 メルカプトプリン フルダラビン
微小管阻害薬 細胞分裂(M期)を停止	タキサン系 バクリタキセル ドセタキセル nab-バクリタキセル ビンカアルカロイド系 ビンクリスチン ビノレリビン その他 エリブリン
トポ阻害薬 DNAの切断・再結合を阻害	トポイソメラーゼI型 イリノテカン ノギテカン トポイソメラーゼII型 エトポシド
抗腫瘍性抗生物質 DNAに入り込み複製を阻害	アントラサイクリン系 ドキソルビシン エピルビシン アムルビシン その他 プレオマイシン マイトマイシンC

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 臓器に特有の毒性と予防・対策

臓器毒性	主な原因薬剤	機序・リスク因子	予防・対策
心毒性	ドキソルビシン等のアントラサイクリン系	累積投与量に依存(不可逆的)。胸部放射線・抗HER2療法で増強	累積投与量の管理、治療前後の心エコー
腎障害	シスプラチン、大量メトトレキサート	尿細管障害/尿中での結晶析出	大量補液・Mg補充/尿のアルカリ化・ホリナート救援
出血性膀胱炎	イホスファミド、大量シクロホスファミド	代謝物アクロレインが膀胱粘膜を障害	メスナの併用、十分な水分摂取
肺毒性	プレオマイシン	総投与量に依存する肺線維症。高齢・腎機能低下で増加	総投与量の管理、咳・息切れの確認
末梢神経障害	タキサン系、ビンカアルカロイド系、オキサリプラチン	累積投与量に依存	症状の聴取と減量・休薬の提案
血管外漏出	アントラサイクリン系、ビンカアルカロイド系	起壊死性薬剤の漏出で組織壊死	投与中の痛み・腫れの確認、デクスラゾキサン(アントラサイクリン)

3 副作用の特徴と発現時期



押さえておきたいポイント

- 5つのグループと細胞周期上の作用点で整理すると、効き方と副作用が理解しやすい
- 臓器特有の毒性は、病院での累積投与量・腎機能の確認と、薬局での症状の聞き取りの両面で管理
- レジメン・検査値・副作用Grade・服用状況を病院と薬局で共有することが、安全な治療継続の鍵